

**Алгоритм координації
медичної благодійної та гуманітарної допомоги,
що надходить в Україну в умовах воєнного стану**

1. МОЗ забезпечує координацію і розподіл медичної благодійної та гуманітарної допомоги, що надходить в Україну по каналах комунікації та взаємодії МОЗ із дипломатичними та іншими інституціями.

Така допомога включає в себе **медикаменти, парентеральне харчування, експрес тести, витратні матеріали (у тому числі пелюшки, рукавички та інші засоби індивідуального захисту), медичні вироби та інструменти, медичне обладнання, витратні матеріали для лабораторного обладнання, медичні меблі, медичний транспорт, мобільні госпіталі (далі – медичне забезпечення),** яка спрямовується в Україну з інших країн світу у зв'язку з військовою агресією росії.

2. МОЗ консолідує інформацію про загальну потребу в медичному забезпеченні від:

- закладів, що підпорядковуються МОЗ;
- закладів охорони здоров'я Національної академії наук України;
- закладів охорони здоров'я та фізичних осіб – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та залучаються до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану (далі – заклади охорони здоров'я) (через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я військових адміністрацій (далі – ДОЗ) верифікується сукупна потреба по регіону);
- структур, які знаходяться в координації Міноборони, МВС та інших сил безпеки і оборони (централізовано через Міноборони, МВС та інші сили безпеки і оборони).

3. МОЗ із залученням необхідної додаткової допомоги на підставі інформації про заплановане медичне забезпечення, яке має заїхати на територію України:

- визначає склади першого вивантаження в Україні;
- забезпечує доставку медичного забезпечення, що надійшло на територію України, на склади, а також сортування там;
- забезпечує подальший облік медичного забезпечення за допомогою єдиної інформаційної системи;
- здійснює розподіл медичного забезпечення відповідно до зібраних агрегованих потреб.

4. Облік залишків на регіональних складах, внесення потреб, а також розподіли медичного забезпечення відбуваються через інформаційно-аналітичну систему «MedData» (далі – ІАС «MedData») (за потреби через координаторів у телефонному режимі).

5. Збір потреб у медичному забезпеченні відбувається:

для закладів, що підпорядковуються МОЗ – через МОЗ із подальшим внесенням в ІАС «MedData» або у телефонному режимі через координатора (за відсутності комп'ютера, світла, інтернету);

для закладів охорони здоров'я Національної академії наук України – через МОЗ із подальшим внесенням в ІАС «MedData» або у телефонному режимі через координатора (за відсутності комп'ютера, світла, інтернету);

для закладів охорони здоров'я – через регіональних координаторів від структурних підрозділів з питань охорони здоров'я із внесенням даних закладами в ІАС «MedData» або у телефонному режимі через координатора (за відсутності комп'ютера, світла, інтернету);

структур, які знаходяться в координації Міноборони, МВС, інших сил безпеки та оборони – через Міноборони (Командуванням Медичних сил ЗСУ) та МВС, інші сили безпеки і оборони з подальшим внесенням в ІАС «MedData».

6. Якщо заклад охорони здоров'я має потребу в медичному забезпеченні, йому необхідно подати її в ІАС «MedData», звернутись до ДОЗ щодо розподілу медичного забезпечення.

Дані щодо потреби подаються з **розрахунку середньомісячної потреби**.

Наступне подання даних про потребу у медичному забезпеченні здійснюється щомісячно або невідкладно в разі виникнення незапланованої потреби (зміна воєнної обстановки в регіоні, виникнення спалахів хвороб тощо).

Така потреба **повинна підтримуватися закладами охорони здоров'я в актуальному стані** та оновлюватися у разі її зміни. При надходженні медичних засобів з будь-яких джерел, відповідальна особа повинна **показати зменшення потреби**. Разом із тим, якщо внаслідок непередбачуваних обставин наявні залишки медичних засобів було втрачено або потреба виросла в наслідок збільшення обсягу надання медичних послуг - необхідно **показати збільшення такої потреби**.

Якщо у вас виникли питання щодо внесення та розрахунку щомісячної потреби або у вас відсутня фізична можливість внести дані по потребі – **звертайтеся до вашого регіонального координатора.**

7. Закриття поданої потреби в медичному забезпеченні здійснюється шляхом:

централізованих закупівель;

закупівель, які роблять військові адміністрації та заклади охорони здоров'я;

благодійної та гуманітарної допомоги.

Пріоритетні позиції для надання медичного забезпечення формуються МОЗ на основі аналізу того, що неможливо покрити через проведення закупівель у швидкому режимі, та передаються до МЗС, країн партнерів, донорів, урядових і неурядових організацій, інших партнерських інституцій з проханням надання медичної гуманітарної допомоги.

8. Розподіли медичного забезпечення, яке надійшло в якості благодійної та гуманітарної допомоги, з центрального рівня робляться на:

заклади, що підпорядковуються МОЗ;

заклади охорони здоров'я Національної академії наук України

структурні підрозділи з питань охорони здоров'я регіонального рівня (далі структурні підрозділи з питань охорони здоров'я роблять розподіли на заклади охорони здоров'я);

централізовано на інституції, визначені Міноборони (Командуванням Медичних сил ЗСУ) та МВС, іншими силами безпеки та оборони.

9. Усі розподіли медичного забезпечення, яке надійшло в якості благодійної та гуманітарної допомоги, робляться на основі внесених даних в ІАС «MedData», у тому числі запити на волонтерів щодо додаткового забезпечення закладів, волонтери верифікують в ІАС «MedData».

10. Розподіл медичного забезпечення готується МОЗ із урахуванням ситуації щодо наявних залишків та потреби у медикаментах, витратних матеріалах та медичних виробках з першочерговою пріоритезацією на покриття потреб у регіонах, що найбільше потерпають від військової агресії російської федерації.

11. Наказом МОЗ від 12.03.2022 № 474 «Деякі питання отримання гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану» отримувачем медичної гуманітарної та благодійної допомоги визначено державну установу «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – ДУ «ЦГЗ»).

Медичне забезпечення постачається на регіональні склади, з якими ЦГЗ укладено договір про відповідальне зберігання.

12. МОЗ взаємодіє з найбільшими волонтерськими ініціативами в частині:

інформування їх про найпріоритетніші потреби та верифікації потреб закладів;

обліку волонтерськими складами медичного забезпечення та його розподілу;

допомоги в залученні ресурсів (за потреби).